# リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月20日（火）

第39号　朝刊



きょうの紙面　▶嚥下・脳卒中　▶制度・介護報酬　▶脳卒中・社会的要因　▶短信 8本


■ 嚥下・脳卒中

## 脳卒中後の嚥下障害161例 MBSImPの意味ある改善は約2〜5点

改善をどこから「意味あり」と読むか。基準の置き方で2点から5点まで幅が出た

脳卒中後に嚥下障害のある患者161例（発症2週〜3か月で回復期リハに入院）を10日間追った前向き多施設観察研究。嚥下造影（VF）のMBSImP咽頭総合スコアが何点下がれば意味のある改善かを、経口摂取の指標FOIS、誤嚥の指標PAS、患者の全体印象PGICを基準に推定した。

スコアは中央値9点から4点へ下がり、平均の改善は4.27点。FOIS・PAS・PGICとの相関はいずれもr>0.3だった。最小臨床重要差（MCID）は基準の置き方で変わり、事前に決めた基準では平均変化で約3点、差の比較で約2点、ROCの切り点は2〜3点。FOISの2段階改善など厳しい基準では約5点に上がった。

追跡は10日間と短く、観察研究である。数字は1つに決まらず、「どの改善を意味ありとするか」とセットで使う必要がある。VFの点数の変化を効果判定やカンファレンスで語るとき、2点動いたのか5点動いたのかを分けて見る目安になる。



MCIDは基準で2〜5点。1つの数字にしない。

出典 Dysphagia ↗

数字で見る

**161例**
脳卒中後の嚥下障害（発症2週〜3か月）

**9→4点**
MBSImP咽頭総合スコアの中央値

**2〜5点**
最小臨床重要差の幅（基準で変動）

■ 制度・介護報酬

## 介護給付費分科会（10/19） 訪問系リハの見直し案が示される

10月19日の社保審・介護給付費分科会で、訪問看護ステーションのPT・OT・STによる訪問看護の現行1回8単位の減算を見直す論点が示された。算定割合は横ばいでも単位数は増え続け、適正化の効果が十分でないという整理で、具体的な単位数は示されていない。委員からは、減算を厳しくすべきという意見と、看護師の訪問とリハ職の訪問を分けて評価すべきという意見が出た。

訪問リハでは、診療未実施減算（1回50単位）



をめぐり、事業所医師の診療による訪問リハを「基本」とする案が報じられた。猶予期間を設け、対面が難しい場合はオンライン診療も使えると明確にする。いずれも審議中の案で、改定の結論ではない。

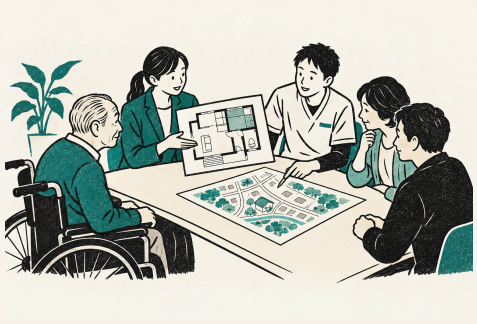
出典 GemMed／POST ↗

■ 脳卒中・社会的要因

## 脳卒中後mRSの人種差2,537例 社会的要因の調整で差は消えた

米国シンシナティ周辺の虚血性脳卒中後に生存した2,537例（32%が黒人）を、退院時・3・6・12か月のmRSで追った。年齢・性別の調整では、黒人は経時的なmRSが悪く（cOR 2.61、95%CI 1.89-3.60）、差は12か月まで続いた。

重症度と治療を加えると1.92、病前の健康状態で1.43となり、社会的決定要因を加えると1.09（0.80-1.47）で有意でなくなった。後ろ向きの観察研究で、米国1地域のデータである。因果は言えず日本にそのまま当てはまるとも限らないが、退院先や支援体制を見る根拠の1つになる。



出典 Stroke ↗

### 短信

〈周術期リハ〉**大腸手術後の早期運動をRCTで予備検証**
30例。術後1・3・5日に理学療法士が介入し、安全・実施可能。SPPBは維持。主要評価を途中変更。 出典 Perioper Med ↗

〈転倒予防〉**低中所得国の高齢者の転倒予防を統合レビュー**
14研究・7か国。運動や家屋改修で転倒や恐怖感が減る可能性。研究数が少なく慎重に読む。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈エビデンス〉**八段錦の傘レビュー、確実性は低い**
261件のレビュー。AMSTAR 2は18件が低、12件が極めて低。多くが低確実性で、推奨とは言えない。 出典 J Evid Based Med ↗

〈作業療法〉**熱傷リハのICFコアセットをOTと患者が検証**
OT14人・患者19人。68コードの8割超が合意、17コードを追加。活動・参加と環境の比重が高い。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈理学療法〉**先端巨大症の膝に15回の理学療法**
寛解後13例と変形性膝関節症の対照13例。疼痛・機能は改善し、こわばりは戻りにくい。小規模。 出典 Endocr Connect ↗

〈教育〉**理学療法学生の共感、模擬体験で高まる**
DPT学生14人。JSE得点が基準より+6.86点（p=.004）。単群の短期で予備的な混合研究。 出典 Gerontol Geriatr Educ ↗

〈栄養・嚥下〉**神経リハのIDDSI導入後は栄養指標が良好**
288例の後ろ向き。退院時のBMI・蛋白・アルブミンが良好。非ランダム化で因果は言えない。 出典 Nutr Clin Pract ↗

〈嚥下〉**高齢入院患者の嚥下ケアを43推奨に整理**
28文書から7領域の推奨。多職種チーム、スクリーニング、退院後の追跡を含む。 出典 J Multidiscip Healthc ↗